

PLEURÉSIE À LIQUIDE CLAIR :

Rappel physiologique

À l'état physiologique, les entrées et sorties de liquide et protéines au niveau de l'espace pleural sont équilibrées et régulées par :

- Le flux osmotique
- La pression oncotique
- La circulation lymphatique

La survenue d'un épanchement pleural est la conséquence d'un déséquilibre entre la production et la résorption du liquide pleural. Ce déséquilibre est soit le fait d'une plèvre pathologique (il s'agit alors d'un exsudat) soit le fait d'un déséquilibre mécanique entre les pressions hydrostatique et oncotique vasculaire (il s'agit alors d'un transsudat).

Diagnostic positif

1. Signes cliniques

A/ Syndrome respiratoire

- Le plus souvent, signe d'origine pleural :
 - Douleurs thoraciques homolatérales
 - Toux sèche, déclenchée aux changements de position
 - Dyspnée en cas d'épanchement important et/ou d'installation rapide. Voir détresse respiratoire aiguë
 - Recherche des signes de mauvaise tolérance : cyanose
 - polypnée
 - hypotension , tachycardie
 - recherche des signes associés :
 - altération de l'état général
 - fièvre
- la présence d'un épanchement pleural peut être complètement asymptomatique et découverte sur une radiographie systématique.

B/ Examen Clinique :

- Inspection : Objectiver un hémithorax immobilisé en cas d'épanchement de grande abondance.
- Le trépied pleurétique : Triade de Troussau
- Palpation : Diminution ou abolition des vibrations vocales.
- Percussion : Matité liquidienne, déclive.
- Auscultation : Diminution ou abolition du murmure vésiculaire.
- L'auscultation peut aussi retrouver :
 - un frottement pleural (aux deux temps respiratoire) en particulier en cas d'épanchement minime.
 - un souffle pleurétique (expiration) au bord supérieur de l'épanchement.

2 Examens complémentaires

A/ Radiographie de thorax de face et de profil

La radiographie de thorax permet de confirmer le diagnostic, d'évaluer l'importance de l'épanchement et de rechercher des signes de complications.

- aspect d'épanchement pleural libre de grande cavité :
 - opacité liquidienne dense homogène déclive.
 - disparition du cul de sac pleural.
- limite supérieure de l'opacité concave en haut et en dedans, formant la ligne de Damoiseau.
- se prolongeant par une ligne axillaire.
- sur le profil opacité homogène déclive avec limite concave vers le haut.

Cas particuliers :

- épanchement unilatéral avec bascule du médiastin controlatéral
- signe de gravité radiologique : Déviation du médiastin (une compression)
- épanchement cloisonné : Opacité localisée avec angle de raccordement à la paroi
- épanchement scissural : Aspect pseudo tumoral sur la radiographie de face, mieux visible de profil.

Ponction pleurale exploratrice

- Dans un premier temps exploratrice, elle permet d'analyser les caractéristiques d'un épanchement et d'orienter le diagnostic.

Indication :

- systématique en présence d'un épanchement sans diagnostic
- en urgence en cas de fièvre associée afin d'éliminer une pleurésie purulente

Contre indication :

- Épanchement pleural minime
- Trouble de la coagulation
- Instabilité hémodynamique

Le point de ponction

guidé par une échographie pleurale, surtout si l'épanchement est enkysté ou de faible abondance.

- Poumon
- Plèvre pariétale
- Épanchement pleural (liquide pleural)
- Aiguille

Résultats et orientation diagnostique :

- analyse macroscopique : permettant d'orienter le diagnostic

- purulent : pleurésie purulente
- sang : hémothorax
- clair , jaune citrin : exsudat ou transsudat
- séro-hématique : exsudat le plus souvent
- aspect blanc lactescent : chylothorax

Diagnostic

- **Biochimie :**

- Taux de protides pleural demandé systématiquement et permet de distinguer les exsudats des transsudats, ce taux varie en fonction de l'état de nutrition du malade

Protides (g/L)	Critères complémentaires (dits de Light)	Nature de l'épanchement
< 25	Non	Transsudat
25 à 35	LDH > 200 UI/L Ou protides pleuraux / sériques > 0,5 Ou LDH pleuraux / sériques > 0,6	Si non → Transsudat Si oui → Exsudat
> 35	Non	Exsudat

- En cas de doute il faut compléter par les critères de light.
- Autres paramètres d'orientation :
 - la glyco- pleurie basse oriente vers une origine infectieuse (<0.6g/l)
 - l'acide hyaluronique : origine asbestosique de l'EPP (pleurésie bénigne ou mésothéliome malin)
 - facteur antinucléaire et rhumatoïde, fraction du complément : orientent vers des EPP des connectivites.
- **Cytologie (anapath) :**
 - Numération et formule, recherche de cellules anormales.
 - **Bactériologie standard :**
 - Sensibilité augmentée en cas d'ensemencement au lit du malade sur flacons d'hémoculture aérobie et anaérobie.
 - **Recherche de BK :**
 - Examen direct et mise en culture.
- C/Examens biologiques :
 - bilan biologique standard :
 - NFS, ionogramme, urée, créatinine
 - LDH, protides
 - bilan inflammatoire : CRP, VS
 - hémocultures en cas de fièvre.
- D/Autres examens :
 - Échographie pleurale :
 - elle n'est pas systématique.
 - Cet examen permet d'affirmer l'existence d'un épanchement liquide pleural avec la présence d'une image anéchogène Péri-pulmonaire.

- L'échographie pleurale fait facilement le diagnostic des épanchements cloisonnés et la différence entre pleurésie et collapsus pulmonaire dans les cas difficiles.
- Enfin, elle permet le repérage précis de l'épanchement, surtout quand il est cloisonné, et guide (en direct ou en différé) les ponctions difficiles.
- biopsie pleurale :
 - indication : Exsudat
 - permet de réaliser un diagnostic anatomopathologique.
- deux méthodes sont utilisées :
 - biopsie pleurale à l'aveugle : Sous anesthésie locale au lit du malade, plus particulièrement indiquée en cas de suspicion de tuberculose ou de cancer. Contre indiquée en cas de trouble d'hémostase (TP<60%, plaquettes<50000/mm³) ou de médicaments anticoagulants ou antiagrégants.
 - vidéothoracique : Chirurgie sous anesthésie générale, biopsie sous contrôle de la vue (augmente la rentabilité de l'examen), elle permet aussi de réaliser un geste thérapeutique, évacuation suivie d'une symphyse pleurale.

*** TDM thoracique :**

- non systématique
- l'épanchement pleural apparaît comme une opacité homogène, déclive mieux visible sur les coupes médiastinales.
- elle permet de rechercher les anomalies pulmonaires sous-jacentes.
- elle permet de définir les limites d'un épanchement cloisonné et de diriger une ponction ou un drainage.

DIAGNOSTIQUE ETIOLOGIQUE :

- L'étiologie des pleurésies est multiple : dominée par les causes infectieuses, tumorales et cardiaques, qui représentent 30 % des épanchements pleuraux. En zone d'endémie tuberculeuse, plus de la moitié des épanchements pleuraux sont d'origine tuberculeuse. Les pleurésies exsudatives restent sans étiologie dans 10 à 27 % des cas.

Exsudats :

1. Pleurésie tuberculeuse :
 2. Elle peut survenir dans les suites immédiates ou à distance d'une primo-infection.
 3. Pleurésie : début progressif, en général isolée (patient non contagieux).
 4. Associée à une fièvre et une altération de l'état général.
 5. Ponction pleurale :
 - liquide citrin.
 - Protides élevés.
 - Liquide à prédominance lymphocytaire (>75%).
 - Glycopleurie basse (<2mmol/l).
 - Élévation de l'adénosine désaminase.
- BK rarement mis en évidence à l'examen direct et culture positive dans seulement 50% des cas.
 - Le diagnostic nécessite souvent une biopsie à l'aveugle ou sous vidéothoracoscopie, mettant en évidence un granulome tuberculoïde.
 - Cellules épithélioïdes et géantocellulaires.
 - Nécrose caséuse.
2. Pleurésies réactionnelles :
 - Épanchement réactionnel à une infection pulmonaire
 - Ponction pleurale :
 - liquide clair
 - stérile : le plus souvent
 - riche en polynucléaires neutrophiles
 - La pleurésie réactionnelle peut se compliquer, avec apparition d'un épanchement cloisonné
 - Facteurs de risque d'évolution défavorable nécessitant le drainage en urgence :
 - pH < 7.20
 - LDH > 1000 UI/L
 - glycopleurie basse
 - liquide non stérile (examen direct et/ou culture)

3. Pleurésie virale :

- diagnostic d'exclusion
- début brutal associé à un syndrome grippal
- épanchement de faible abondance
- pouvant être associé à une péricardite
- évolution spontanément favorable en 1 à 2 semaines

4. Pleurésie néoplasique :

- La plupart des pleurésies néoplasiques correspondent à des localisations secondaires, mais rarement à une atteinte néoplasique primitive.
- **Pleurésies métastatiques :**
- Épanchement récidivant ; parfois douloureux
- Liquide sérohématique avec prédominance de lymphocytes
- Présence de cellules néoplasiques sur la ponction pleurale dans 50 % des cas
- Le diagnostic est souvent réalisé sur la biopsie pleurale (à l'aveugle ou par vidéothoracoscopie)
- **Cancers le plus souvent responsables :**
- Poumon chez l'homme
- Sein chez la femme
- Hémopathies (hodgkin-lymphome ou leucémie)
- Ovaire
- Mélanome

4. Mésothéliome pleural :

- cancer primitif de la plèvre
- favorisé par l'exposition à l'amiante
- apparition tardive par rapport à l'exposition (20-30 ans)
- exsudat riche en acide hyaluronique (non spécifique)
- rarement présence de cellules anormales sur la ponction

5. Iatrogènes :

- De nombreux médicaments peuvent être responsables d'épanchement pleural, mais il s'agit d'un diagnostic d'exclusion : l'amiodarone, dérivés de l'ergot de seigle.
- Épanchement pleural survenant dans le cadre de lupus induit (positivité des anticorps anti-histones) : bêtabloquants, hydralazine, isoniazide.
- Une pleurésie peut survenir dans les années qui suivent une radiothérapie thoracique.

Transsudats :

- Les transsudats sont observés le plus souvent dans des situations évocatrices
 1. Insuffisance cardiaque gauche ou globale : pleurésie souvent bilatérale (unilatérale parfois)
 2. signes d'insuffisance cardiaque associés : cardiomégalie, œdème pulmonaire
 3. amélioration sous diurétiques
- 2. Syndrome néphrotique :
 - épanchement bilatéral
 - hypoprotidémie associée à une protéinurie
- 3. Insuffisance hépatocellulaire :
 - épanchement pleural le plus souvent droit, parfois bilatéral
 - signes de cirrhose associés : hépatomégalie, ascite, circulation veineuse collatérale
- 4. Autres :
 - péricardite chronique constrictive
 - myxœdème

Traitement :

1 TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

A/ ponction évacuatrice :

- les ponctions évacuatrices constituent une méthode simple de l'évacuation de l'épanchement, elles sont souvent itératives et quotidiennes, présentant l'avantage d'être moins invasives que le drainage conventionnel malgré le risque de complications (hématome, pneumothorax, infection).

B/ oxygénothérapie :

- elle doit être instaurée en cas de pleurésie de grande abondance et en cas de pleurésie tumorale associée à des lésions pulmonaires.

C/ kinésithérapie respiratoire :

la kinésithérapie respiratoire doit être précoce et prolongée, elle permet d'améliorer la compliance thoraco-pulmonaire et prévenir l'apparition des séquelles pleurales.

La kinésithérapie a toute sa place dans la prise en charge de la pathologie pleurale

D/ corticothérapie :

- les corticoïdes sont dotés d'un effet anti-inflammatoire, prescrits dans les pleurésies surtout tuberculeuses pour prévenir la survenue des séquelles pleurales de type pachypleurite

2. Traitement local :

- drainage pleural :

Il est utilisé systématiquement lorsque l'épanchement est abondant, récidivant et devant tous les épanchements ayant des critères de gravité :

- liquide purulent
- taux de LDH > 1000

on utilise un drain de gros calibre, parfois plusieurs si l'épanchement est cloisonné, dans ce cas de figure le scanner thoracique prend tout son intérêt permettant de réaliser un état des lieux pulmonaires et de poser le drain sous radioguidage. Il est classique de retirer le drain lorsque la production du liquide devient inférieure à 500ml/j.

3. Traitement étiologique :

A/ traitement des pleurésies tuberculeuses

- les régimes thérapeutiques appliqués sont issus des recommandations du programme national de lutte antituberculeuse.

D/ traitement des pleurésies d'origine cardiaques :

- le traitement consiste à diminuer l'hypertension veineuse, augmenter la fonction cardiaque avec des diurétiques, des digitaliques et associer un traitement pour la réduction de la post charge, la plupart du temps, cette prise en charge est suffisante. En cas d'épanchement volumineux, une ponction peut être réalisée lentement sans aspiration pour éviter l'œdème.

CONCLUSION :

La prise en charge des pleurésies impose tout d'abord de rechercher les signes de mauvaise tolérance, sur le plan respiratoire et hémodynamique qui nécessitent un geste d'évacuation en urgence. Tout épanchement doit être analysé afin de poser l'indication d'une évacuation en urgence (l'importance de l'épanchement ou ses caractéristiques biologiques permettent de poser un bon diagnostic), compte tenu des complications potentielles. Les pleurésies constituent une affection assez fréquente, cependant un diagnostic précoce et une prise en charge correcte pourraient améliorer le pronostic afin d'éviter d'éventuelles complications